

BELUCCI, G., *Psicosis: de la estructura al tratamiento*, **Letra Viva, Buenos Aires, 2009**

Introducción

*Ich lese es heraus aus deinem Wort,
aus der Geschichte der Gabärden,
mit welchen deine Hände um das Werden
sich ründeten, begrenzend, warm und weise.
Du sagtest leben laut und sterben leise
und wiederholtest immer wieder: Sein.
Doch vor dem ersten Tode kam der Mord.
Da ging ein Riss durch deine reifen Kreise
und ging ein Schrein
und riss die Stimmen fort,
die eben erst sich sammelten
und dich zu sagen
und dich zu tragen
alles Abgrunds Brücke.*

*Und was sie seither stammelten,
sind Stücke
deines alten Namens.*

Rainer Maria Rilke
*Das Stunden-Buch*¹

¿Cómo pensar las coordenadas del dispositivo analítico en el campo de las psicosis? Con este interrogante, perentorio para quienes nos acercábamos a esta clínica, comenzamos a trabajar un grupo de analistas en el marco de nuestra rotación por el Servicio de Atención Primaria I del Hospital Borda. Las búsquedas bibliográficas que cada uno realizaba se intercalaban con un espacio compartido de lectura y discusión, en el que dábamos cuenta de nuestros hallazgos y preguntas. Nos sorprendió la heterogeneidad de ese material, que en muchos casos no pasaba de testimonios clínicos muy valiosos, pero de los que no nos parecían extraídas todas sus consecuencias lógicas. Del grupo inicial, tres de nosotros perseveramos en esa búsqueda, que dio lugar a un breve artículo en el que esbozábamos un programa de trabajo, a partir de un relevamiento de lo ya pensado en este campo clínico².

Paralelamente, me fui adentrando en la investigación conceptual sobre las psicosis, acompañando mi actividad docente en la Cátedra I de Psicopatología de la Universidad de Buenos Aires, prolongada con los años en la Cátedra de Psicopatología de UCES, así como en diversos cursos de posgrado, grupos de estudio, conferencias y presentaciones. Fue creciendo, en ese recorrido, una convicción: que la investigación conceptual y la investigación clínica estaban unidas en una verdadera continuidad topológica, y que dar cuenta de las coordenadas de la clínica de las psicosis era solidario de establecer rigurosamente la posición psicótica respecto de la estructura. Quedaba trazado, en consecuencia, un trayecto que vinculara los grandes ejes de la conceptualización psicoanalítica de las psicosis con la posibilidad de avanzar en la teorización de los tratamientos. Ese trayecto se fue afinando en el marco de los cursos dictados en el Hospital Borda, y en mi tarea como supervisor pude poner a prueba sus premisas. Este libro, entonces, podría considerarse a la vez un resultado de ese trabajo y un punto desde el cual retomarlo.

La clínica de las psicosis es un campo abierto en el psicoanálisis *después de Freud*. Freud tenía una determinada posición respecto de la clínica de las psicosis. Ni siquiera empleaba, en sus comienzos, el término «psicosis», que empezó a utilizar en 1924. Antes de esa fecha se refería a las «neurosis narcisistas», y antes de 1914 ni siquiera había una categoría nosológica diferencial con respecto a las neurosis. Freud, entonces, tenía una posición bastante taxativa, que era que no había análisis posible de las neurosis narcisistas. Lo fundamentaba en la idea de que —supuestamente— en las neurosis narcisistas no había posibilidad de transferencia.

Freud se mantuvo firme en esta posición a lo largo de toda su obra. No es que no hiciera, en sus comienzos, algunos intentos de analizar pacientes diagnosticados como «paranoicos». Fue justamente a raíz de los fracasos en esas tentativas que se fue diluyendo su optimismo inicial. Para Freud, en consecuencia, no había análisis posible, y no sólo análisis, no había tratamiento analítico posible de los pacientes psicóticos. Fueron los analistas más cercanos a la Escuela Inglesa los que empezaron a incursionar tanto en la clínica como en algunas conceptualizaciones que dejaban abierta la posibilidad de un tratamiento analítico de las psicosis. No voy a ahondar en esos desarrollos. Sí me interesa el punto a partir del cual Lacan retomó la cuestión.

Lacan escribió un texto en el año 1958 al que tituló *De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis*. Esto es interesante por dos razones. Por un lado, porque estaba implícito desde el título mismo que habría un tratamiento posible de las psicosis, pero también porque no avanzó él mismo en la conceptualización de la clínica de las psicosis. Es algo que dejó abierto como posibilidad, pero en verdad la *Cuestión preliminar*, como su nombre lo indica, implica considerar la posición de las psicosis con respecto a la estructura como algo previo a toda posibilidad de tratamiento.

La idea de estructura es una de las especificidades de Lacan con respecto a Freud. No encontramos, en Freud, una idea *formal* de estructura, aunque Lacan va a retomar cuestiones trabajadas por Freud a partir de esta idea de estructura, que es preciso situar. Ahora bien, ¿qué implica exactamente nuestra referencia a la estructura? No se trata, por ejemplo, de un concepto equivalente al de «aparato psíquico» en Freud, si bien Lacan resituó de alguna forma el aparato psíquico freudiano en términos de estructura, lo cual supone ya una vuelta con respecto a Freud. Como primera cuestión, destaquemos que la estructura en Lacan no sería algo que podamos pensar por fuera del lenguaje. No es que el sujeto psicótico esté fuera del lenguaje, ya que éste es constitutivo de todo sujeto. Algo que quede fuera del lenguaje estaría, en verdad, fuera del ámbito de lo humano. En todo caso, el sujeto psicótico tiene una relación con la palabra que plantea no su exclusión absoluta de esta función, pero sí al menos una complicación diferente a la que el sujeto neurótico tiene con ella. El psicótico no *dispone* de la palabra del mismo modo en que puede disponer el neurótico de ella.

Introduce la idea de «estructura» en singular, y esto también es un tema de discusión teórica entre los analistas, ya que es usual la referencia a *las* estructuras clínicas, de las que se afirma que son tres: neurosis, perversión y psicosis. No es que este modo de plantear la cuestión carezca de apoyatura en articulaciones efectivamente propuestas por Lacan. Se entiende por «estructuras clínicas» los distintos modos de organización, cada uno con una lógica propia, delimitados claramente por Lacan sobre la base de los antecedentes freudianos, y que no serían reductibles entre sí. Es decir, no habría pasaje de un modo de funcionamiento neurótico a uno psicótico, ni viceversa, y lo mismo podría sostenerse con respecto a la perversión. Es una idea que no todos los psicoanalistas a lo largo de la historia han compartido. Es, entonces, dentro de cierta manera lacaniana de pensar que, hoy en día, se habla de las estructuras clínicas.

No se trata aquí de objetar esa tripartición, pero hay elementos en la obra de Lacan para pensar que cuando utiliza el término «estructura», en principio habría que hablar en singular. Cuando cursé Psicopatología, la docente que dictaba los teóricos en ese momento empezó afirmando algo que me resultó enigmático, porque también yo hablaba de *las* estructuras clínicas. Escribió esto:



Y dijo: «La estructura es esto», es decir, el matema del Otro barrado. Me llamó mucho la atención, ya que pensaba —como casi todos en la Facultad— que *las* estructuras eran tres. Esto, entonces, me resultó enigmático y me llevó a pensar a lo largo de estos años. Creo que hay buenos argumentos en Lacan para pensar que, efectivamente, él define la estructura de este modo y que, en relación con esto, que sería común a neurosis, pervisión y psicosis, lo que hay —o no hay— son determinadas operaciones.

Quiero dejar sentadas una serie de ideas que nos orientarán en nuestro recorrido. El punto de partida es, entonces, que la estructura puede entenderse, en su formulación más elemental, como equivalente al Otro barrado. La primera idea, que es algo así como la piedra fundamental del psicoanálisis, es que no es posible pensar la subjetividad sin una referencia al Otro. Esto está en Freud. En un recordado pasaje de la *Psicología de las masas...*, afirma que en la vida psíquica contamos siempre con el otro, luego de lo cual ubica distintas posiciones en las que viene a jugar este otro en la vida psíquica. Por otra parte, Freud todo el tiempo —si uno se toma la molestia de meterse mínimamente en su obra—, cuando piensa los síntomas, cuando piensa las fantasías, cuando piensa cualquiera de los articuladores del aparato psíquico, siempre hace referencia de alguna manera a la dimensión de un otro. Ya sea como objeto, ya sea como ese lugar tan particular que él define como «el Otro escenario» cuando habla del inconsciente, siempre esta dimensión está presente.

Lo que hizo Lacan con esto fue formalizarlo, es decir, darle un estatuto y una categoría particulares a algo que en Freud se dejaba leer, pero que Freud no elevó nunca a la jerarquía de concepto. Lacan fue el primer psicoanalista en sostener con todo rigor lógico que es imposible pensar al sujeto sin el Otro, y en extraer de ello sus consecuencias clínicas y teóricas. Ahora bien, ¿por qué, después de Lacan, lo escribimos de este modo?

Pasamos entonces a una segunda idea, o más bien dos. Como se sabe, Lacan —y esto sí es una innovación lacaniana— se caracteriza por pensar la estructura en términos de los tres registros. Creo que esto le aporta una precisión a la reflexión sobre una serie de cuestiones que con los términos freudianos resulta difícil de alcanzar a veces. Muchos atolladeros de la conceptualización freudiana se ordenan a partir de la separación de estas tres dimensiones. Señalemos ahora que el Otro, tal como Lacan lo formaliza en su enseñanza, involucra los registros simbólico, imaginario y real. Cuando hablamos del Otro estamos hablando del modo es que estos tres se anudan, para expresarlo en términos más tardíos. En su expresión más radical, puede definírselo como un lugar virtual, equivalente al modo en que el lenguaje determina la constitución del sujeto.

Una tercera idea es que el psicoanálisis, como práctica y como saber, se caracteriza por otorgar un valor constitutivo a la dimensión de la *falta*. Esto que nos parece tan obvio, porque estamos inmersos en cierto discurso, en verdad no es ninguna obviedad: hay muchas teorías psicológicas, muchas concepciones filosóficas en las que la cuestión de la falta no está en juego, excepto como algo contingente. No se la considera una dimensión inherente a la subjetividad. Por supuesto, la cuestión de la falta no es en sí misma simple. Basta una lectura de las conceptualizaciones del *Seminario 4* para saber que esto es algo que tiene su complejidad, y que requeriría un desarrollo extenso en sí mismo.

Si, en consecuencia, articulamos el carácter fundamental del Otro a la cuestión de la falta, llegamos a nuestro punto de partida:



No hay manera de pensar al Otro que no sea ésta. El Otro —según lo entiende el psicoanálisis— está necesariamente afectado de una falta que le es inherente, y que resulta decisiva para la constitución del sujeto. Se trata de un supuesto crucial, porque hay una idea que circula en el «sentido común lacaniano» —a mi juicio un malentendido— de que en las psicosis esto no sería posible. Veremos si, en nuestra revisión de las formulaciones lacanianas, encontramos que el problema es que esto no existe en las psicosis, o bien qué posición podemos recortar en las psicosis con respecto a esto, que claramente no es la que tiene un neurótico. Si lo pensamos de esta manera, podríamos decir que *la estructura* es esto y que neurosis, perversión y psicosis serían posiciones con respecto a esto.

¿Cómo se llega de la estructura en singular a alguna de esas tres posiciones que son neurosis, perversión y psicosis? Se pueden recortar, en la lectura de Freud y Lacan, una serie de *operadores* que posibilitan determinados movimientos en la estructura. Para que esos movimientos sean posibles, se requerirá a su vez que determinadas *operaciones* se hayan producido. Esas operaciones conciernen primordialmente al modo en que incide la *Ley* en la estructura así definida. Desde ya, esto nos lleva directamente a la cuestión del Padre, que podríamos definir como un *nudo*. En efecto, estaba allí, antes del nacimiento del psicoanálisis —que se inicia con el duelo de Freud por la muerte de su padre— y llega hasta las últimas formalizaciones de Lacan sobre topología borromea. La cuestión del Padre nos atraviesa.

¿Cómo pensar el Padre? En términos muy amplios, podemos definirlo como un operador que se caracteriza por tener, respecto de la estructura, una propiedad *ordenadora*. En esto difiere de cualquier otro operador que podamos recortar. El Padre, en sus distintas formulaciones, siempre es aquel operador que posibilita un ordenamiento de los elementos de la estructura. Intentaremos más adelante aislar otros operadores y caracterizarlos, aunque desde ya hay que señalar que no alcanzará con esto. La idea es pensar su juego recíproco y los movimientos que permiten.

Volviendo a la idea de *operaciones* que introdujimos hace poco, algunas de estas operaciones podemos pensarlas como constitutivas de una posición. Constituida ésta —y con esto trabajamos, excepto en la clínica con niños pequeños— serán posibles una serie de movimientos, estando otros excluidos. Hay determinados movimientos, por ejemplo, posibles dentro de la neurosis y que no lo son para un psicótico. Recordar esto es una saludable brújula toda vez que se nos presenten en la clínica las tentaciones «neurocéntricas», que harían del sujeto psicótico una versión algo tosca o inacabada de un neurótico, o directamente su equivalente. Por otra parte, esta posición es consecuente con lo que nos define como psicoanalistas: hacer de determinados imposibles algo que no sólo padezcamos, sino que nos abra el juego de un conjunto de posibles. Recortando la imposibilidad, se ordena un campo de trabajo donde en caso contrario sólo habría confusión.

Seguiré en este libro dos vías para avanzar en la conceptualización de la clínica de las psicosis. En primer término, lo que Lacan llamaba la *cuestión preliminar*, relativa a la posición de las psicosis respecto de la estructura. Nos encontraremos aquí con un problema, ya que no puede avanzarse en la formalización del mismo modo que respecto de las neurosis y perversiones. En la posición psicótica hay algo que resiste la formalización en términos *universales*, lo que no implica que no puedan trazarse ciertas *coordenadas*. En segundo lugar, la posibilidad de abstraer, a partir de los testimonios de la práctica con pacientes psicóticos, líneas orientadoras para esa práctica, no sin el (necesario) pasaje por la «cuestión preliminar». Me propongo, en consecuencia, seguir estas dos vías, en ese orden y no por casualidad. Podríamos decir que sin la «cuestión preliminar» no hay «tratamiento posible». Deslindando la posición del sujeto psicótico en la estructura, ubicamos los imposibles a partir de los cuales nuestro trabajo se ordena.

De acuerdo a esta secuencia, comenzaremos por una revisión del recorrido que llevó a Freud a delimitar progresivamente las categorías de neurosis y psicosis, a partir de la inclusión inicial de la llamada «paranoia» y de la confusión alucinatoria en la clase de las neuropsicosis de defensa. En el capítulo 1, rastreamos el origen de las nociones freudianas y la producción del concepto de defensa, impensable por fuera de la inven-

ción del dispositivo analítico. Producido este concepto, consideraremos de qué manera Freud lo refirió a la llamada «paranoia», postulando la proyección como su mecanismo específico, en estrecha relación con una intuición: que la defensa paranoica implicaba el fracaso en el funcionamiento de cierta ley. En el capítulo 2, retomaremos el problema de la defensa paranoica desde otro ángulo: el que se refiere a la articulación de escenas y de tiempos implícita en toda historización neurótica, y que en la paranoia no es situable. En el capítulo 3, encontraremos a un Freud que, quince años más tarde, reformula el problema del mecanismo, ligándolo a una conceptualización sobre el «complejo paterno», a propósito de su lectura de las *Memorias* del Presidente Schreber. El capítulo 4 nos permitirá despejar muchas de las aporías que la investigación freudiana había dejado planteadas, a partir de la delimitación entre «neurosis de transferencia» y «neurosis narcisistas», efectuada en la *Introducción del narcisismo*. En su interrogación sobre la economía libidinal en ambos tipos de neurosis, Freud establecerá que lo que se constituye en las primeras como un circuito, da lugar en las segundas a una detención. La fantasía quedará allí como lo que posibilita que el circuito entre el yo y sus objetos se mantenga. Correlativamente, Freud producirá en este texto otros importantes conceptos, como los de Ideal del yo y conciencia moral. En el capítulo 5, nos dedicaremos a rastrear la diferencia y la articulación entre lo que Freud denomina «proceso de la enfermedad» y el «intento de restitución», problema fundamental en cualquier consideración de la cuestión de las psicosis.

En la segunda sección, nos centraremos en el modo en que Lacan retomó el legado de Freud concerniente a las psicosis. Tomaremos como referencia un escrito: *De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis*. Sin desconocer que antes y después de este texto hay en la obra de Lacan importantes desarrollos sobre las psicosis, interesa el esfuerzo de formalización de la estructura que allí tiene lugar, y que nos permitirá darle a los conceptos un grado de rigor de otro modo inalcanzable. En el capítulo 6, trazaremos con Lacan las coordenadas de la estructura para todos los seres hablantes sujetos a la Ley del Padre, que ordena el lazo del sujeto al Otro y soporta los campos simbólico e imaginario que se conjugan, a su vez, en la estructura de la realidad. Sentadas estas bases, el capítulo 7 nos verá abocados a la elucidación de las características que asume el lazo al Otro, así como los órdenes simbólico e imaginario y el campo de la realidad, en las psicosis, en las que el operador paterno no está en funciones.

La tercera sección supondrá, finalmente, pasar de la «cuestión preliminar» al «tratamiento posible». Comenzaremos, en el capítulo 8, por un pormenorizado examen de los problemas que supone, en la clínica de las psicosis, articular las dimensiones de la política, la estrategia y la táctica, propuestas por Lacan en *La dirección de la cura*. Revisaremos, en ese trabajo, la categoría de semblante y su íntima relación con los discursos, como paso previo a cualquier reflexión sobre la cuestión de la transferencia. Allí nos detendremos a pensar, por una parte, aquellas posiciones que sostuvieron su inexistencia —comenzando por la del propio Freud— y aquellas otras que postularon que hay una transferencia psicótica. Dentro de estas últimas, tendremos que analizar distintas lecturas, para avanzar en la conceptualización de su estructura. Nos referiremos, también, al estatuto de las «suplencias», término invocado con frecuencia y no siempre esclarecido, para concluir con una indicación sobre la *posición de apertura* que esta clínica reclama. En los tres capítulos siguientes, nos moveremos entre los niveles de la estrategia y la táctica, para desarrollar tres líneas posibles de trabajo, según primen las soluciones delirantes (capítulo 9), la eclosión alucinatoria (capítulo 10) o el arrasamiento subjetivo que muchas veces la psicosis produce (capítulo 11). La premisa de esta división es que ha resultado inconducente avanzar en una única dirección —la del apuntalamiento del delirio—, como cierta clínica «clásica» quiso establecer, con el resultado de un importante número de fracasos, allí donde el delirio no aparecía como una coordenada axial. En el capítulo 11, nos referiremos especialmente al *dispositivo de taller*, por su importancia en el trabajo con pacientes subjetivamente arrasados, así como al difícil asunto de lo que llamaremos «la historia nunca escrita», y la operatoria que es pensable sobre la misma. El capítulo 12 lo dedicaremos a tres puntos que no sería con-

veniente omitir, y con los que cerraremos nuestro trayecto: la *pluralización* que esta clínica supone, el recurso a la internación y la utilización de psicofármacos.

No quisiera concluir esta introducción sin referirme al carácter *polifónico* que necesariamente tiene esta obra. Si el psicoanálisis no es una *Weltanschauung*, es porque incluye es su fundamento la falta y, en particular, toda vez que esa falta concierne al *saber*. Ese punto de radical no-saber con el que operamos demostró su fecundidad no sólo en la clínica, sino en la elaboración teórica misma, vía indicada con toda claridad por Freud y por Lacan, que abrevaron en otros discursos para fundar, el uno, y renovar, el otro, el campo del psicoanálisis. Esa apertura, es preciso retomarla en las discusiones entre analistas, que con demasiada frecuencia ignoran las producciones de sus pares. A tono con esta premisa, coexisten en estas páginas una diversidad de voces y discursos. No están jerarquizados según el mayor o menor prestigio de quienes los detentan, sino por el *tempo* y por la lógica de una interrogación que aquí se prosigue, y en la que cada cual revelará su impronta. Ello no desconoce la potencia de la novedad, sino que la inscribe en la dirección trazada por Lacan y que nos compromete: la de reinventar, cada vez, el psicoanálisis.

Buenos Aires, julio de 2009

Nota

¹ “En tu palabra lo interpreto/ desde la historia de los gestos/ con los cuales tus manos, en torno al devenir,/ se curvaban, moldeándolo, cálidas y sabias./ Dijiste *vivir* en voz alta, *morir* en voz baja/ y siempre repetiste: *ser*./ Pero un asesinato se anticipó a la muerte./ Una desgarradura atravesó tus círculos maduros/ y vino un grito/ y arrebató las voces/ que ya empezaban a reunirse/ allí, para decirte,/ y llevarte,/ puente de todo abismo. // Y lo que desde entonces balbucean/ son fragmentos/ del nombre antiguo tuyo”. Rainer Maria Rilke. *El libro de las horas*.

² Cf. BELUCCI, G., KLIGMANN, L. & VALFIORANI, M., *Coordenadas para una clínica psicoanalítica de las psicosis*. En: www.elsigma.com, sección *Hospitales*, 2004.